



SUPERVISÃO CLÍNICA · LÓGICA PSICOLÓGICA

Baixa adesão à terapia x relação terapêutica dialética

*Quando o manual não alcança a pessoa. Uma virada de
estratégia — da psicoeducação para o vínculo — e as
perguntas diagnósticas que precisam ficar abertas enquanto
isso.*

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

Júlio Gonçalves

MSc · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

**Comunidade Lógica
Psicológica**

Uma comunidade para quem quer:

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, com pensamento crítico e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas e construção em rede.

Clique aqui e saiba mais



O ESSENCIAL

- Ψ **Psicoeducação não funciona com quem não quer estar ali.** Explicar melhor não produz adesão; a virada proposta foi trocar a postura de especialista pela construção de vínculo.
- Ψ **Compromissos pequenos, ancorados no que ela quer.** A estratégia do pé na porta parte dos projetos da própria paciente — não dos objetivos do tratamento.
- Ψ **Autorrevelação como intervenção, não como desabafo.** O terapeuta nomeia a própria dificuldade em ajudar. O alvo é criar motivação relacional onde a técnica não chega.
- Ψ **A pergunta diagnóstica precisa ficar aberta.** Dissociação, traços antissociais e características autistas produzem comportamentos parecidos — e o erro custa caro nos dois sentidos.
- Ψ **Validar potencial sem alimentar grandiosidade.** Elogiar esforço e projetos, não as consequências dos atos.

O caso, em uma página

Mulher muito jovem, em acompanhamento há alguns meses, com dezenas de sessões realizadas. O histórico inclui **internação anterior por desregulação grave** e comportamentos autolesivos, além de forte resistência ao tratamento ambulatorial — que acontece por pressão familiar e externa, e não por escolha dela.

Quadro

- Ψ **Diagnósticos** de transtorno de personalidade *borderline*, transtorno do espectro autista com baixa necessidade de suporte, e traços de personalidade antissocial.
- Ψ **Falhas de adesão** ao acompanhamento médico e medicamentoso, apesar da intervenção de vários psiquiatras.
- Ψ **Desregulação emocional severa**, inversão do ciclo sono-vigília e uso abusivo de álcool.
- Ψ **Condutas de risco**, incluindo comportamentos de perseguição a um ex-parceiro, agressões físicas e situações de alto risco em via pública.
- Ψ **Responsabilização judicial** por danos causados a terceiros, sem demonstração de arrependimento ou autocrítica.

O contexto que mantém

A história é marcada por um **ambiente permissivo**, com cuidadores que não impuseram limites nem consequências. Hoje, familiares seguem habilitando as condutas. A terapeuta pondera sobre a

necessidade de internação; a família recusa a via voluntária e prefere **esperar por uma nova crise**.

O que a terapeuta observou, e é o ponto de partida

A paciente **usa a terapia como validação superficial**, sem engajamento com mudança: responde quando é do seu interesse, e recorre ao “não lembro” ou à desregulação como forma de escapar da responsabilização. Não é falta de inteligência nem de recursos — é uma relação com o tratamento que ainda não é de tratamento.

A pergunta diagnóstica que precisa ficar aberta

Boa parte da discussão foi ocupada por uma questão difícil: as condutas agressivas e o baixo senso de realidade são **manifestações dissociativas** ligadas ao quadro *borderline*, ou refletem **traços antissociais**?

A especialista convidada trouxe um alerta pertinente: pacientes com traços antissociais podem **emular sintomas dissociativos** para se esquivar de responsabilidades. E complementou com uma leitura da própria relação: a paciente pode estar usando o *setting* para controlar cuidadores e terapeuta, posicionando-se como vítima para não se engajar com a mudança.

O erro simétrico, que vale registrar

A advertência é útil e precisa vir com o seu contrário. **Dissociação é frequente e genuína em pacientes com transtorno da personalidade *borderline*** (Korzekwa et al., 2009), e ler como manipulação uma resposta dissociativa real produz invalidação — que é exatamente o mecanismo que agrava esse quadro.

Some-se a isso a sobreposição fenotípica entre **condições do espectro autista e transtorno *borderline*** (Dudas et al., 2017): dificuldades de reciprocidade, de leitura social e de expressão afetiva podem ser lidas como frieza ou cálculo quando não são. Num caso com os três elementos na mesa, a hipótese que se fecha cedo é a que erra.

A conduta que decorre disso não é escolher, e sim **observar sob condições** — que foi, de fato, o que a supervisão propôs adiante ao orientar o monitoramento da resposta da paciente à autorrevelação.

Risco e coordenação — acréscimo deste material

Sinalizando o acréscimo

A supervisão concentrou-se na estratégia relacional. Esta seção curta cobre a camada de risco, que não foi discutida e que num caso com histórico de internação, autolesão, uso abusivo de álcool e condutas de alto risco não pode ficar implícita.

- Ψ **Avaliação de risco periódica e registrada**, distinta da formulação de processos — e revista quando o quadro muda, não só quando há crise.
- Ψ **Critérios de internação combinados antecipadamente** com a paciente, com a família e com a psiquiatria: o que caracteriza a necessidade, quem aciona, por qual via. Esperar a próxima crise para decidir é decidir no pior momento possível.
- Ψ **Coordenação com a psiquiatria** como parte do plano, e não como encaminhamento paralelo — sobretudo num caso em que a não adesão medicamentosa é central.
- Ψ **Plano de crise por escrito**, acessível à paciente e a quem convive com ela.
- Ψ **Limites do terapeuta que atende sozinho**. A DBT prevê equipe de consultoria justamente para casos assim; atender caso de alto risco isoladamente é fator de desgaste e de erro.

Nada disso concorre com a estratégia relacional descrita adiante. São camadas simultâneas: o vínculo é o que torna o tratamento possível, e o manejo de risco é o que mantém a paciente viva enquanto o vínculo se constrói.

A virada: abandonar a psicoeducação

A recomendação mais clara do encontro: **abandonar a psicoeducação tradicional**, que se mostrou ineficaz para este perfil, e concentrar o esforço em fortalecer a relação terapêutica.

Faz sentido pela análise anterior. Se a paciente está em tratamento por pressão externa e usa a sessão como validação, explicar melhor não muda nada — o problema não é falta de informação. A postura de especialista, aqui, alimenta justamente a dinâmica de controle que se quer evitar.

Autorrevelação como intervenção

A proposta concreta: a terapeuta usar a **autorrevelação genuína** para expressar as limitações que enfrenta ao tentar ajudar — nomear a própria dificuldade diante da ausência de adesão, de coração para coração.

O objetivo é criar uma **motivação relacional**: que a paciente considere a medicação não por imposição técnica, mas pelo vínculo. Para quem responde mal a autoridade e bem a interesse próprio, é uma das poucas portas abertas.

O critério que separa intervenção de desabafo

A autorrevelação do terapeuta tem alguma sustentação empírica quando é **breve, dirigida ao paciente e a serviço do trabalho** — e não quando transfere a ele o cuidado com o estado emocional de quem atende (Henretty & Levitt, 2010). A diferença prática é simples de checar: depois da fala, quem fica responsável por consolar quem?

Monitorar a resposta

A orientação seguinte é o que transforma isso em método: **observar como a paciente responde**.

- Ψ Se houver **empatia emocional**, usar isso para aprofundar o trabalho.
- Ψ Se a resposta for de **empatia fria**, apenas cognitiva, **registrar sem confrontar** — e esperar o momento em que houver vínculo estruturado o bastante para sustentar o confronto.

Repare que isso também é o teste diagnóstico da seção anterior, feito na prática em vez de na discussão.

Compromissos pequenos e validação sem grandiosidade

Pé na porta

A estratégia sugerida é a do **pé na porta** — obter compromissos pequenos, ancorados nos **próprios desejos da paciente**: morar sozinha, cursar o que a interessa. É uma técnica clássica de comprometimento gradual (Freedman & Fraser, 1966), incorporada às estratégias de *commitment* da DBT.

O ponto crítico é a âncora. Metas colaboradas a partir do que ela quer não disparam a sensação de estar sendo controlada — que é o gatilho confiável de resistência neste caso. Metas do tratamento, apresentadas como tais, disparam.

Validar potencial, não consequência

Uma distinção fina e importante

Validar as potencialidades da paciente — sonhos, inteligência, projetos — **sem reforçar grandiosidade**. Na prática: elogiar o **esforço e os objetivos**, e não as consequências dos atos.

É a diferença entre reconhecer alguém e admirá-la pelo que ela fez de errado sem se abalar. A primeira constrói alavanca; a segunda alimenta exatamente o traço que preocupa.

Os dois caminhos

Foi proposto um exercício de valores derivado da ACT: construir com a paciente **dois caminhos** — o atual, com os problemas que ele acumula e a inscrição que renderia numa lápide, e o caminho que ela desejaria viver. O objetivo é alinhar expectativas de vida e dar a ela um critério próprio de comparação.

Vale a mesma cautela de qualquer exercício confrontativo: com vínculo insuficiente, ele vira acusação. Com vínculo, vira espelho.

Sem protocolo fixo

O encerramento reforçou algo que atravessa toda a discussão: **não existe protocolo fixo** para este caso. A orientação foi confiar na própria sensibilidade clínica e ajustar conforme a resposta da paciente — o que, dito de outro jeito, é a definição de prática baseada em processos aplicada a um caso em que os manuais não alcançam.

O que fica para a sua clínica

- Ψ **Quando a psicoeducação não pega, o problema não é a explicação.** Verifique de quem é o objetivo do tratamento.
- Ψ **Ancore compromissos no que o paciente quer**, não no que você quer para ele.
- Ψ **Autorrevelação é intervenção se for breve e a serviço dele.** Cheque quem consola quem depois.
- Ψ **Não feche a hipótese diagnóstica cedo.** Dissociação, traços antissociais e características autistas produzem comportamentos parecidos — e o erro invalida ou desprotege.
- Ψ **Elogie esforço e projeto, nunca a consequência do ato.**
- Ψ **Combine critérios de crise antes da crise.** Decidir internação no meio de um episódio é decidir no pior momento.
- Ψ **Caso de alto risco pede equipe.** Atender sozinho é fator de erro, não de mérito.

Referências

1. Dudas, R. B., Lovejoy, C., Cassidy, S., Allison, C., Smith, P., & Baron-Cohen, S. (2017). The overlap between autistic spectrum conditions and borderline personality disorder. *PLoS ONE*, 12(9), e0184447.
2. Freedman, J. L., & Fraser, S. C. (1966). Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 4(2), 195–202.
3. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment. *Clinical Psychology Review*, 82, 101908.
4. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Acceptance and commitment therapy* (2ª ed.). Guilford Press.
5. Henretty, J. R., & Levitt, H. M. (2010). The role of therapist self-disclosure in psychotherapy: A qualitative review. *Clinical Psychology Review*, 30(1), 63–77.

6. Kohlenberg, R. J., & Tsai, M. (1991). *Functional analytic psychotherapy*. Plenum Press.
7. Korzekwa, M. I., Dell, P. F., Links, P. S., Thabane, L., & Fougere, P. (2009). Dissociation in borderline personality disorder: A detailed look. *Journal of Trauma & Dissociation*, 10(3), 346–367.
8. Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
9. Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2ª ed.). Guilford Press.
10. Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). *Motivational interviewing: Helping people change* (3ª ed.). Guilford Press.
11. Salekin, R. T. (2002). Psychopathy and therapeutic pessimism: Clinical lore or clinical reality? *Clinical Psychology Review*, 22(1), 79–112.

NOTA DE MÉTODO

Material de estudo desidentificado. Foram generalizados ou removidos: idade exata, datas e número de sessões, valores de condenação, medida de funcionamento intelectual, projetos específicos da paciente, composição familiar e circunstâncias dos episódios. O histórico de internação e de comportamentos autolesivos é referido de forma sumária, **sem descrição de métodos ou episódios**. Um dado de saúde referente a acompanhamento médico continuado foi generalizado para “acompanhamento médico”, por não ser necessário ao raciocínio clínico e por ser fortemente identificador.

Dois acréscimos foram feitos. Primeiro: a seção sobre **risco e coordenação de cuidado**, ausente da discussão, e que num caso com esse histórico não pode ficar implícita. Segundo: ao alerta — pertinente — de que traços antissociais podem levar à emulação de sintomas dissociativos, foi acrescentado o **erro simétrico**: dissociação genuína é frequente no transtorno da personalidade *borderline*, e há sobreposição fenotípica documentada entre condições do espectro autista e esse quadro, de modo que dificuldades de reciprocidade e de expressão afetiva podem ser lidas como cálculo quando não são. Ler resposta dissociativa real como manipulação produz invalidação, que é justamente o mecanismo que agrava o quadro. As duas leituras precisam permanecer abertas.

Os assuntos operacionais do encontro foram omitidos. O nome da terapeuta supervisionada e dos demais participantes não é mencionado. As referências foram acrescentadas para dar respaldo formal a conceitos discutidos sem citação explícita; nenhuma citação foi construída para preencher lacuna. Este material registra raciocínio clínico de supervisão e **não substitui** avaliação individualizada.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

Verifiquei de quem é o objetivo do tratamento antes de insistir em psicoeducação.

Ancorei os compromissos nos projetos do próprio paciente.

Usei autorrevelação breve e a serviço dele — e checei quem ficou consolando quem.

Registrei a resposta à autorrevelação em vez de confrontá-la de imediato.

Mantive mais de uma hipótese diagnóstica aberta diante de comportamentos ambíguos.

Considere sobreposição com características autistas antes de ler frieza como cálculo.

Elogiei esforço e objetivos, e não as consequências dos atos.

Combinei critérios de crise e de internação antes da próxima crise.

Busquei equipe ou consultoria em vez de sustentar o caso sozinho.

MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O PDF guarda o que você escrever.

1. Que paciente seu está em terapia por pressão de outra pessoa? Como isso muda o que é possível fazer?

2. Que compromisso pequeno, ancorado num desejo do paciente, você poderia negociar amanhã?

3. Escreva uma autorrevelação possível para um caso seu — e cheque se ela serve a você ou a ele.

4. Que comportamento de um paciente seu você leu como manipulação? Que outras leituras cabem?

5. Como você distinguiria empatia emocional de empatia cognitiva numa sessão?

6. Que elogio você já fez que pode ter reforçado o padrão em vez do esforço?

7. Os critérios de crise dos seus casos graves estão combinados por escrito? Com quem?